

HOOLEKANDE- JA TERVISHOIUASUTUSTE TULEOHUTUS

Koostas:

Jaak Jaanso

nõunik

Lääne päästekeskus

Sisukord

1. TULEKAHJUST	2
1.1 Vanasõnaraamat tulekahjust	2
1.2 Tulekahju areng.....	2
1.3 Tulekahjud hoolekande- ja tervishoiuhoonetes	3
1.4 Tulekahjude ülevaade viie aasta lõikes	3
2. TULEKAHJUDE ENAMLEVINUD PÕHJUSED, NENDE VÄLTIMINE.....	4
3. ENAMLEVINUD TULEOHUTUSNÕUETE RIKKUMISED, NENDE VÄLTIMINE.....	6
3.1 Tuletõkkesektsioonid	6
3.2 Tuletõkkeuks.....	7
3.3 Tuletõkke paarisustel puuduvad sulgumisühtlustid (takistusseadmed).....	9
3.4 Hoolekandeaastuste majutusruumide ustel puuduvad evakuatsioonisulused .	10
3.5 Evakuatsiooniteede ustel puuduvad evakuatsioonisulused	10
3.6 Evakuatsiooniuste väljavahetamisel ei arvestata suluste valikul inimeste arvuga 11	
3.7 Ehitise kasutamisel ei arvestata kasutajate arvu piirangutega	12
4. TULEKAHJUHÄIRE KORRAL	13
5. TULEKAHJU KORRAL	13
6. EVAKUATSIOON	13
6.1 Tulekahjuõppus.....	14
6.2 Evakuatsiooni lihtsustavad abivahendid	15
7. KASULIKUD LINGID.....	16

1. TULEKAHJUST

1.1 Vanasõnaraamat tulekahjust

- varas jätab nagi seina, tulekahju ei sedagi
- tuluke on vaenlane, keda tuleb karta
- kui punane kukk laulab katusel, siis on kõik lõppend
- tuli on hää sulane, aga paha peremees
- tule kõht on suur
- tulekahju ja kirikuvitsa üle ei või keegi parastada

Seega juba vanal ajal teati, et tulekahju on üks väga ebameeldiv tegelane:

- ta võtab kõik
- teda tuleb karta
- temaga kaasneb tühjus
- ta on paha peremees
- tal on suur kõht
- tema üle ei ole võimalik kahjurõõmu tunda



1.2 Tulekahju areng

Tulekahju vajab tekkimiseks ja arenemiseks kolme elementi:

- põlevmaterjal
- õhuhapnik
- süüteallikas

Kui ükskõik milline komponent eemaldada, siis tulekahju ei teki.

Tulekahju levik on uskumatult kiire:

Tulekahju algetapp võtab aega ainult **3 minutit**.

Temperatuur tõuseb 300 kraadini.

Oluline on selle aja jooksul tulekolle kustutada või ruumidest väljuda ning uksed ja aknad sulgeda.

Alates 4. minutist levib tulekahju väga kiiresti. Eristuvad mürgised gaasid. Temperatuur tõuseb järsult: neljandal minutil 600 kraadini. Lae all on kuumus kõige kõrgem, põrandal veidi madalam.

<https://www.youtube.com/watch?v=rpzgBEDHX3Y>

1.3 Tulekahjud hoolekande- ja tervishoiuhoonetes

Ohvriterohkeimad tulekahjud Eesti lähiajaloo:

9.02.1996 – tulekahju Tallinna psühhiaatriaiglas, kus hukkus üheksa ja vigastada sai seitse inimest. Tulekahju põhjustas lahtise tule allikas madratsite hoiuruumis.

9.04.1997 – tulekahju Pärnumaal Halinga hooldekodus, kus hukkus kaheksa ja vigastada sai 14 inimest. Tulekahju põhjustas suitsetamine voodis.

20.02.2011 – tulekahju Haapsalu väikelastekodus, kus hukkus kümme ja vigastada sai kaks inimest. Tulekahju põhjustas lahtise tule allikas koridoris välisukse vahetus läheduses asunud tugitoolil.

1.4 Tulekahjude ülevaade viie aasta lõikes

	2015	2016	2017	2018	2019	Kokku
Tugikodu	1	0	0	0	1	2
Asenduskodu	0	0	0	1	2	3
Üldhooldekodu	1	0	2	8	3	14
Koolkodu	0	0	1	1	0	2
Sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus	1	3	3	1	2	10
Erihooldekodu	0	3	3	4	0	10
Haigla	4	6	4	3	1	18
	7	12	13	18	9	59

Keskmiselt põleb Eestis igas kuus üks hoolekandehoone või haigla. Seda on palju.

Arvestades haiglate ja hoolekandehoonete eripäradega:

- kasutajatelt ei saa eeldada ruumide tundmist
- neil on piiratud või puudulikud eeldused iseenda ohutuse tagamiseks

on üsna suur tõenäosus, et iga tulekahjuga võivad kaasneda ka traagilised tagajärjed hukkunute näol.

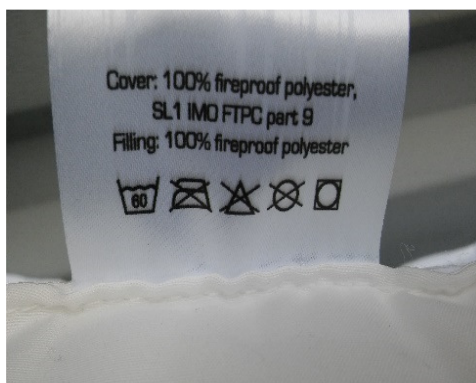
2. TULEKAHJUDE ENAMLEVINUD PÕHJUSED, NENDE VÄLTIMINE

1) 21-l juhul kuritahtlik süütamine, neist 11-l juhul süütas patsient voodi

- Soetada tulekindlad voodipesud, madratsid ja voodid.
- Tavaline madrats, tekk ja padi on üsna head põlevmaterjalid, mis süttivad kergesti. Spetsiaalsed raskesti süttivad voodimaterjalid tagavad tulekahju aeglase arengu, tänu millele on kahjud tunduvalt väiksemad või hoopis olematud.

Tondi Tulekaitse OÜ vahendab Järven'i raskesti süttivat vooditekstiili, mis on toodetud eriti keeruliste ja kõrge riskiga objektidele (kinnipidamisasutused, psühhiaatriaiglad, vanglad jne). Saadaval erinevad toonid ja suurused. Voodikomplekt ühele inimesele ca 400 eurot.

Wendre ASis toodetavat tulekindlat voodikomplekti samuti jaemüügis ei ole. Saab ettevõttest tellida. Partii peaks olema vähemalt 300 voodikomplekti. Voodikomplekt ühele inimesele - padi koos padjapüüriga, tekk koos tekipüüriga, voodilina ja madratsikate tootmine ca 100 eurot.



- Hoolekandetasutuses kehtestada kord, et hoolealuste suitsud ja süütevahendid (tikud, välgumihkel) asuvad personaliruumis lukustatud kapis. Vajadusel väljastab töötaja korraga ühe sigareti ja peale suitsetamist tagastab patsient süütevahendi.
- Ka töötajate suitsud ja süütevahendid peaksid asetsema lukustatud kapis. Ühes kohas, kus traagiliste tagajärgedega tulekahju aset leidis, olid töötajate suitsud ja süütevahendid isiklikes lukustamata kappides. Patsiendid olid sellest teadlikud, et sealt saab nii suitsu kui tikku.
- Mittepõlevast või raskesti süttivast materjalist sisustuselemendid (kapid, voodid, diivanid, istmed, vaibad, kardinad) ühiskasutuses olevatesse ruumidesse. Sobivad metallkapid ja lamineeritud pinnakihi kapid. Mitte kasutada tavatekstiiliga kaetud ja poroloonitüüpi diivaneid ja istmeid. Ühes ohvriterohkemas tulekahjus oli tulekahju tekkimise koht koridoris välisukse vahetus läheduses asunud tugitoolil. Tooli täidis oli poroloonist ja see oli kaetud puuvillasest riidest kattega. Poroloon on kergesti süttiv materjal, põledes eraldub kõrge temperatuur ja palju mürgist suitsu. Eraldub soojust toob endaga kaasa materjali edasise sulamise ja laialivoolamise

suurele pinnale. Puuvillane riie on kergestisüttiv põlevmaterjal, mille süütamiseks on piisav väikese võimsusega süüteallikas (nt tikuleek, tulemasina leek, küünlaleek jms).

- Mitte kasutada sünteetilisest materjalist vaipu. Käitub tulekahjus analoogselt porolooniga. Kasutada tuleks vaipkatteid, mis ei ole kergesti süttivad. Tootja annab alati tootega kaasa sertifikaadi, milles muu info seas on märgitud ka tuletundlikkus. Sobib vähemalt D_{FL}-s1 tuletundlikkusega vaipkate. Kui vaiba tuletundlikkus ei ole teada, ei sobi see hoolekandenasutuse või haigla ruumidesse.
- Mitte kasutada küünlaid. Küünal võib ümber kukkudes süüdata läheduses paiknevad põlevmaterjalid. Eriti ohtlik on küünalde kasutamine jõulude ajal kuusepuu kaunistamiseks või siis, kui küünla ümber pannakse põlevmaterjalist pärg või muud põlevmaterjalist kaunistused.

2) 18-l juhul lahtise tule kasutamisel, neist 14-l juhul suitsetamine

Suitsetamisest põhjustatud tuleõnnetuste põhjusteks on peetud eelkõige kolmandatest riikidest toodud odavate suitsude suitsetamist, mis hooletusse jätmisel ei kustu, vaid hõõguvad edasi ning lahtisest tubakast ise valmistatud sigarettide suitsetamist.

- Jälgida, et patsiendid ei tarbiks illegaalseid sigarette. Legaalsete sigarettide pakil on Euroopa Liidu liikmesriigi aktsiisimärk ja need on isekustuvad. Isekustuvate sigarettide ümbrispaber on piiratud põlemisomadustega ning sellel on nn „takistusribad“. Kui põlemine jõuab takistusribani ja kui suitsetaja ei mahvi sigaretti, siis sigaret kustub ise. Seevastu tavapärane sigaret hõõgub ilma mahvimata iseseisvalt filtrini välja ning põhjustab sellega tuleohtu ümbritsevale põlevmaterjalile. Väljastpoolt Euroopa Liitu toodud sigaretid ei oma standarditega reguleeritud põlemisomadusi. Nt. Venemaal toodetud sigaretid ei ole isekustuvad, selliselt ohtlikud.
- Tuleks leida võimalus pakkuda patsiendile suitsetamisest loobumise nõustamise teenust. Haigla patsiendid ei ole üldjuhul ravisutusse sattunud vabatahtlikult, selliselt ei saa ilmselt eeldada, et nad päevapealt suitsetamisest loobuvad. Küll aga tuleks nõustamise teenust pakkuda hoolekandenasutuste hoolealustele.
- Suitsetajast patsienti või hoolealust mitte panna magamisruumi või palatisse üksi, vaid koos teistega. Siis hoiavad teised tal silma peal.
- Reguleerida ehitises ja territooriumil suitsetamine. Tubakaseaduses on sätestatud:
 - 1) suitsetamine on keelatud **laste hoolekandenasutuse** ruumides ja asutuse piiratud maa-alal
 - 2) suitsetamine on lubatud **tervishoiuteenust** osutavas asutuses või ettevõttes üksnes suitsetamisruumis. Samas ehitise valdajal ei ole suitsetamisruumi eraldamise kohustust.

Muudel juhtudel otsustab ruumis või piiratud maa-alal suitsetamise lubamise vastavalt ruumi või piiratud maa-ala valdaja enda äranägemisel. Selliselt on võimalik haigla või hooldekodu sisekorraeeskirjas vms dokumendis keelata ehitises ja territooriumil suitsetamine. Selline keelamine võib tekitada aga olukorra, kus suitsu tehakse salaja kõikvõimalikes nurgatagustes kohtades, WCdes või koguni voodis. Et salaja suitsetamist vältida, on tuleohutum sisustada ehitises suitsetamisruum või territooriumil suitsetamise koht.

3) 12-l juhul rike elektriseadmes ja -paigaldises (süttis elektrikilp, seinakontakt, nõudepesumasin, riiete kuivatuskapp, elektriventilaator, elektriboiler).

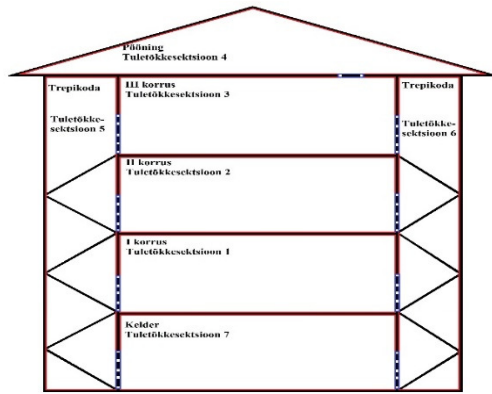
- Elektrisüsteemid vananevad kasutamisega, seetõttu tuleb nende korrasolekut kontrollida. Elektripaigaldisele tuleb kindla perioodi järel teha korraline audit, selle sagedus sõltub paigaldise liigist ja vanusest. Täpsem info TTJA kodulehel <https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/elekter/infomaterjalid>
- Tavaisikud võivad teha vaid lihtsamaid elektritöid, näiteks lampide ja kaitsemete vahetamine, elektrijuhtmete ja -seadmete demonteerimine ning pistikupesade ja lülitikaante (näiteks tapeetimise või värvimise ajaks) eemaldamine pingevabas olukorras. Muudel juhtudel tuleb pöörduda elektriku kutsega isiku poole.
- Elektriseadmete kasutamisel tuleb arvestada, et ükski asi ei ole igavene. Kui tekib silmaganähtav sädelus elektriseadme sisse/välja lülitamisel, on see ohumärk, et ühenduskontaktid on väsinud ja seade vajab remonti või tuleb see välja vahetada. Kõige ohtlikumad on seadmed, mis tarbivad lühikese ajaga palju voolu nt kiirveesoojendid. Kui kuskil on veel nõukogudeaegseid elektriseadmeid või alumiiniumtraadiga elektrijuhtmeid, siis on viimane aeg need välja vahetada. Eriti ohtlik on vaskjuhtme ja alumiiniumjuhtme omavahel ühendamine.
- Mitte lubada patsientidel või hoolealustel kasutada enda toodud elektrikütteseadmeid (puhur, radiaator jms). Nende töötamise ajal kinni katmine on põhjustanud tulekahjusid.
- Patsientide või hooldusaluste elektriseadmed tuleks kriitilise pilguga üle vaadata. Silmnähtavalt aegunud või ohtlike seadmete kasutamine tuleb ära keelata.

3. ENAMLEVINUD TULEOHUTUSNÕUETE RIKKUMISED, NENDE VÄLTIMINE

Kõige suurem probleem on tuletõkkeustega seonduv

3.1 Tuletõkkeseksioonid

Tulekahju põhjustatud kahju vähendamiseks jaotatakse hoone tuletõkkeseksioonideks. Tuletõkkeseksioon on ümbritsevatest hoone osadest eraldatud nii, et tule levik välja- või sissepoole seda osa on ettemääratud aja jooksul tõkestatud.



3.2 Tuletõkkeuks

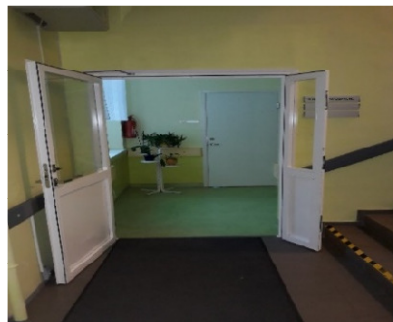
Tuletõkkeseinas olev tuletõkkeuks vastab teatud tulepüsivusnõuetele, on isesulguv ja riivistuv. Tuletõkkeuks, mis asub evakuatsiooniteel, peab olema ilma abivahendita (võtmeta) avatav. Tuletõkkeukse tunneb ära sellest, et lengil ja ukselehel on tähistus, samuti on ukselehe mõlemale poolele silmade kõrgusele paigaldatud märk:



**Automaatselt
sulguv
tuletõkkeuks
hoia vaba**

**Tuletõkkeuks
hoia kinni**

➤ Tuletõkkeuksi hoitakse avatud asendis



Põhjuseks on toodud:

- Kui suletud, siis ratastooliga liikumine on raskendatud
- Need on nii rasked, et inimesed ei jaks neid avada
- Töötajatel ja patsientidel on selliselt mugav liikuda

Lahendus: Tuletõkkeukse lahti hoidmiseks paigaldatakse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga (edaspidi ATS) ühendatud uksemagnetid. Uksemagnetid hoiavad tuletõkkeuksed avatud asendis, ning vabastavad nad tulekahju korral (rakendub ATS), nii et ukseid sulguksid. Pöörduda ettevõtte poole, kes tulekahjusignalisatsiooni hooldab, nemad paigaldavad. Maksab ca 60 eurot, lisandub ühendusjuhtme maksumus ja tööraha, selliselt ca 100 eurot ukse kohta.



➤ Tuletõkkeuksed ei sulgu tihedalt

Põhjuseks on toodud:

- Ei teadnud, et tuletõkkeuksi peab hooldama
- Arvasime, et ATSi hooldaja peab kontrollima

Lahendus: Tuletõkkeuksi tuleb regulaarselt hooldada. Tuletõkkeukse tootja annab uksega kaasa paigaldus- hooldus- ja kasutusjuhendi. Nt Saku Metall tuletõkkeuste hooldussagedus on mitte harvem kui kuue kuu tagant. Uksel, mis paikneb evakuatsiooniteel, mitte harvem kui kolme kuu möödudes. Kui ehitise valdaja ei saa ise töödega hakkama, on võimalik uksetootjaga sõlmida hooldusleping.

Tuletõkkeuste hoolduse käigus:

- Kontrolli isesulgumisvõimet (ATS korral automaatset sulgumist, hooldaja kontrollib üks kord aastas)
- Kontrolli riivistumist
- Kontrolli kinnipüsimist
- Kontrolli tuletõkke paarisukse sulgemisühtlust ja automaatriivide toimimist. Vajadusel reguleeri
- Kontrolli lengi ja ukselehe vahelisi pilusid (lõtk mitte rohkem kui 2-3 mm) tihendite olemasolu ja toimimist. Vajadusel vaheta tihend. Tihendid on iseliimuvad, hind oleneb paksusest ja laiuselt, näiteks TTT20x2,0 jooksev meetri hind on 1.75 eurot
- Kontrolli metalluste värvipindade vigastuste olemasolu. Kui värvipind on kahjustunud, võta ühendust uksetootjaga, kes teeb ise värviparandused või juhendab värviparanduste tegemist

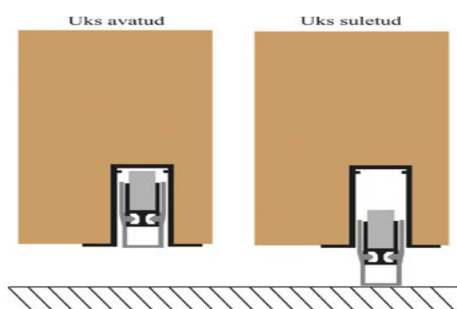
- Puhasta ja määri riivid, lukud, sulgurid, uksehinged

➤ Tuletõkkeukselt on eemaldatud lävepakk

Põhjenduseks on toodud: ei ole võimalik ratastoolis liikuda

Lahendused:

- Lävepakku on võimalik tasandada mitteläbivajuva kaldpleki või -liistuga.
- Pöörduda tuletõkkeukse tootja poole, kes leiab sobiva lahenduse. Lävepakk asendatakse nt automaatselt allalaskuva uksetihendiga (hind ca 80 eurot 95 cm), mis ukse sulgudes sulgeb ukselehe ja põranda vahelise pilu. Sellisel juhul peab põrand olema tehtud mõlemal pool ust vähemalt 20 cm ulatuses mittepõlevast materjalist.



3.3 Tuletõkke paarisustel puuduvad sulgumisühtlustid (takistusseadmed)

Põhjenduseks on toodud: Algselt oli nii, ei ole teadlik, et peab olema

Lahendus: Ilmselt oli algselt paarisukse üks uksepool passiivne, mis tavaolukorras on suletud asendis. Pöörduda tuletõkkeukse tootja või ATSi hooldaja poole, kes paigaldab sulgumisühtlusti, mis tagab, et ukselehed sulguvad õiges järjekorras. Aktiivne uksepool sulgub passiivsest hiljem, tagades selliselt ukselehtede tiheda sulgumise.

Automaatne sulgumisühtlusti:



Mehhaaniline sulgumisühtlusti:



3.4 Hoolekandeesutuste majutusruumide ustel puuduvad evakuatsioonisulused

Põhjendused on üksteisele vasturääkivad – soovitakse, et magamistubasid ei lukustataks ja vastupidi, nähakse ette lukustamise vajadust

- Hoolealused sulgevad end tuppa ja nende üle ei ole võimalik järelevalvet teha.

Lahendus: Eemaldada magamistubade ustelt lukusüdamikud ja katta avaus kahe metallkattega. On sobiv lahendus tervishoiuasutuste palatite ustel, ei ole sobiv lahendus hoolekandeesutuste majutusruumide ustel.



- Inimesel peab olema privaatsus ja ta peab saama ennast majutusruumi lukustada. Nõue tuleneb sotsiaalministri määruse nr 58 §st 6 lõikest 5, mis sätestab, et hoolekandeesutuse magamistubade uksed peavad olema lukustatavad.

Lahendus: Paigaldada hoolekandeesutuse majutusruumide ustele lukusüsteem (nõ libliklukk), mis võimaldab ust seestpoolt võtmeta nii lukustada kui ka avada. Lisaks peab jääma personalitöötajale võimalus väljastpoolt ust avada.



3.5 Evakuatsiooniteede ustel puuduvad evakuatsioonisulused

Põhjenduseks on toodud: Patsiendid lähevad kontrollimatult õue. Soov on nende liikumist piirata.

Lahendus: Lukutootjatel on välja pakkuda erinevaid lahendusi:

- Uksele paigaldatakse lukusüsteem, mis rakendub tulekahjusignalisatsiooni rakendumisel. Tavaolukorras on uks lukustatud. Ukse jälgimiseks paigaldatakse valvekaamera, mis ühendatakse monitoriga, mis paikneb ruumis, kus on ööpäevaringne valve. Samuti on võimalik uksele paigaldada elektriline alarmsignaali, mis annab ukse avamisel häire.
- Võtmepesa asemele paigaldatakse südamikuavasse plastikkattega evakuatsiooniväändenupp



3.6 Evakuatsiooniuste väljavahetamisel ei arvestata suluste valikul inimeste arvuga

- 150 või enam inimest - horisontaalse latiga evakuatsioonisulustus ehk paanikasulustus

Puuterõhtlatt



Lükandrõhtlatt



- 31-149 inimest - lingi või surunupuga evakuatsioonisulustus



- Kuni 30 inimest - väändenupp (nö libliklukk)



3.7 Ehitise kasutamisel ei arvestata kasutajate arvu piirangutega

Tuleohutusest lähtuvalt oleks kõige ohutum ehitis betoonist kast, mis on täidetud liivaga. Sellisel ehitisel ei ole aga praktilist väärtust, selliselt jaotatakse hooned tuleohutusest lähtuvalt:

- 1) tulekindel (tähis TP1) – üldjuhul hoone kandekonstruktsioon tulekahjus ei varise (betoon, betoonpaneelid jne). Ehitis püsib püsti ka pärast tulekahju.
- 2) tuldtakistav (tähis TP2) – hoone kandekonstruktsioonide tulekahjus varisemise aeg on lühem kui tulekindla hoone suhtes ettenähtud aeg (seinad betoonpaneelidest, vahelagi puidust).
- 3) tuldkartev (tähis TP3) – hoone kandekonstruktsioonide tulekahjus varisemise aeg ei ole määratud (seinad ja vahelagi puidust).

Tulekindlas ehitises on kasutajate arv piiranguta. Tuldtakistavas ja tuldkartvas ehitises on kasutajate arvu piirangud, mida tuleb jälgida:

		TP2	TP3
Hoolekandeesutus, haigla	ühekorruseline ehitis	100 kohta	10 kohta
	kahekorruseline ehitis	25 kohta	ei lubata

Ehitise kasutajate arv määratakse ehitusprojekti. Kui ehitise tuleohutusklass või projektijärgne kasutajate arv ei ole teada, tuleb teha ehitise tuleohutusaudit. Tuleohutusauditi tegemise kompetents on tuleohutusekspert, tase 6 kutsetunnistusega isikul.

4. TULEKAHJUHÄIRE KORRAL

Igat ATSi rakendumist tuleb võtta tõesena ja alustada kohehelt tegevustega:

- Liigu keskseadme juurde
- Vaigista häirekellad
- Vaata tabloolt häireteate asukohta
- Selgita paiknemisskeemide abil välja häiret andnud tsooni või anduri täpne asukoht
- Liigu seda asukohta kontrollima

Enne ruumi sisenemist, kus on oletatav tulekahju, kontrolli, et see oleks ohutu, katsudes ust ja veendudes, et see ei ole soe. Juhul, kui uks on soe või ülevalt kuumem kui alt, ei ole mõistlik sellist ust avada.

- Valehäire korral vii süsteem tavaolukorda
- Tulekahju korral vajuta lähimat tulekahjuteatenuppu

5. TULEKAHJU KORRAL

- Helista viivitamatult häirekeskusesse 112. Häirekeskusesse teavitamisel saadetakse välja päästemeeskond.
- Alusta inimeste evakueerimisega
- Võimaluse korral asu tuld kustutama

Kustuta ainult juhul, kui oskad ja see on võimalik. Kui kustutamine ei ole võimalik või muutub võimatuks, lahku ruumist ja sulge enda järel ruumi uks.

- Päästjate saabumisel anna neile infot

6. EVAKUATSIOON

Sõltuvalt hoones viibivate inimeste seisundist ning hoone ehituslikest võimalustest on inimeste evakueerimiseks võimalik kasutada erinevaid strateegiaid. Evakuatsiooni on võimalik korraldada:

- **massilisena**, see tähendab kõikide hoones viibivate inimeste kohest väljumist. See strateegia on kasutatav asutustes, kus hoolealuseid ei ole väga palju ning nad ei ole sõltuvad töötajatest. Pärast häiresignaali alustatakse iseseisvalt evakueerumisega hoonest välja ohutusse kohta. Kogu hoone evakueeritakse üheaegselt ning lahenduseks piisab sektsioneeritud evakuatsioonitrepikodadest;
- **etapilisena**, see tähendab hoones viibivate inimeste järk-järgulist eemaldumist tulekahju tekkekohast. Seda strateegiat kasutatakse asutustes, kus on hoolealuseid,

kes sõltuvad töötajatest. Selle käigus evakueeritakse hoolealused kõigepealt ohtlikust piirkonnast järgmisesse tuletõkkesektsiooni, millesse on teatud aja vältel takistatud tule ja suitsu levik. See peaks andma piisavalt aega tegeleda liikumisvõimetute inimeste evakuatsiooniga. Vajalik on, et igal korrusel oleks vähemalt kaks eraldi tuletõkkesektsiooni.

- **passiivsena**, see tähendab, et võimaluse korral jäädakse kohale ning oodatakse päästmist. Sellise strateegia rakendamine tuleb kõne alla näiteks operatsioonisaalides ning intensiivravipalates, kus haigete kiire transport on väga keeruline ja ohtlik. Selle strateegia korral on vajalik, et ruumid, milles viibivad hoolealused, on eraldi tuletõkkesektsioonid. Samuti peab olema välditud suitsu levimise võimalus ruumides (juhitavad suitsutõkestid, eraldi ventilatsioonisüsteem). Kui taolist strateegiat rakendatakse, on siiski vajalik ka plaan inimeste hoonest välja toimetamiseks.

6.1 Tulekahjuõppus

Vähemalt üks kord aastas tuleb töötajatel läbida evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus. Siin kehtib tarkusetera - raske õppustel, kerge lahingus. See tähendab seda, et õppuste käigus tuleks valida võimalikult keerulised stsenaariumid ja olukorrad, milliseid siis lahendatakse ja hilisema kokkuvõtte tegemisel ka läbi arutatakse ning kitsaskohtadega ka edaspidi arvestatakse.

Õppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Tulekahjuõppuse kohta koostatakse õppuse järgselt kirjalik kokkuvõte.

Päästeameti koostatud e-õppematerjalid õppuse teooria osa läbiviimiseks leiab Moodle keskkonnast.

NB! Moodle keskkonna kasutamiseks vali Google Chrome veebilehitseja. Esmakordsel Moodlesse sisselogimisel peab iga osaleja looma endale konto. Järgmistel kordadel saab keskkonda sisse logida juba registreeritud kasutajana.

- Sisene Moodle veebikeskkonda - <https://moodle.edu.ee>
- Leia kursus nimega "Tuleohutus haiglatele ja hoolekandeesutustele"
- Vali "Iseregistreerumine (Õppija/Student)"
- Sisesta kursusele registreerimise võti (kursuse võtme saad kirjutades ohutusjarelevalve@rescue.ee)

Nüüd saad läbida kursuse teooria osa ja teha testi.

Praktilises osas simuleeritakse tulekahju olukorda ning harjutatakse erinevaid vajalikke tegevusi. Praktilises osas tuleks läbi harjutada just raskemaid ettetulevaid olukordasid. Ja seda vähima võimaliku tööol oleva personaliga (on hooldekodusid, kus on öisel ajal tööol üksnes üks personalitöötaja). Kindlasti ei ole võimalik ühel inimesel kõiki abivajajaid korraga aidata, selliselt tuleb väga täpselt kõik tegevused läbi mõelda. Patsientide või hoolealuste paigutamisel ehitisse tuleks sellega siis ka eelnevalt arvestada -

liikumispuudega patsiendid tuleks paigutada üksnes hoone esimesele korrusele. Seejuures on vajalik kindlasti veenduda, et välisuksest ohutusse kaugusesse liikumist ei sega välistrepp (et oleks õues kaldtee). Kõrgemale korrusele paigutamisel tuleks ratastooli kasutav patsient paigutada magamisruumi koos liikumisvõimelise patsiendiga, kes siis õnnetuse korral teda abistaks. Praktilise osa üheks eesmärgiks peab olema ka see, et personal oskab kasutada ATS keskseadet, otsida tulekahju tekkekohta paiknemisskeemidelt ning oskab ja julgeb kasutada tulekustutit.

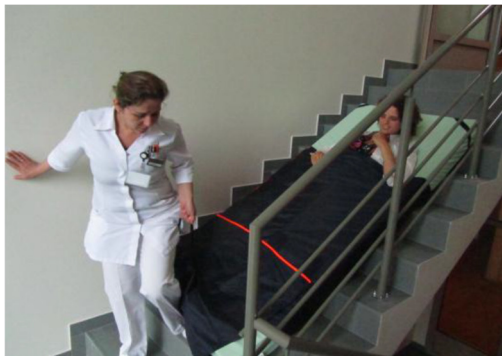
Kirjalikus kokkuvõttes käsitletakse:

- 1) Õppuse läbiviimisega seotud faktilised andmed
- 2) Tuvastatud asjaolud
- 3) Eesmärkide täitmist
- 4) Ettepanekud tuleohutuskorralduse muutmiseks

Tulekahjuõppust võib korraldada ise, kui selleks on olemas teadmised ja oskused. Samas on soovitatav kasvõi teatud perioodi tagant (nt 1x3a jooksul) tellida teenus tuleohutusfirmalt, kes omab asjatundlikku nägemust ja kogemust tuleohutuse tagamisel.

6.2 Evakuatsiooni lihtsustavad abivahendid

Päästelohisti paigaldatakse voodi ja madratsi vahele ning on pidevalt voodis valmis kasutamiseks. Tulekindel, sobib patsiendi liigutamiseks ka trepil, personali vajadus – 1 inimene. Päästelohisti on eriti vajalik vähemalt ratasteta vooditesse, kus on lamav patsient ja kõikide lamavate patsientide või hoolealuste vooditesse nendes hooneosades, kus puudub võimalus horisontaalseks evakuatsiooniks ohutusse kohta. Ka igal pool mujal haiglates ja hooldekodudes, kus on puuduliku liikuvusega hoolealuste suur osakaal, on päästelohistid soovitatavad. Seda ka juhul, kui tulerisk pole suur.



Päästemadrats on laialt levinud evakuatsioonivahend, mis võimaldab nii patsiendi kandmist kui lohistamist, sealhulgas treppidel. Päästemadratseid hoitakse enamasti õepostidel ja/või trepikodades seina külge kinnitatuna. Evakueerimisvajaduse korral asetatakse evakueeritav päästemadratsile, kinnitatakse rihmadega ja lohistatakse ohutusse kohta sarnaselt päästelohistiga. Päästemadrats on hea valik haiglate ja hooldekodude sellistesse allüksustesse, kus puuduliku liikumisvõimega patsientide või hoolealuste osakaal on väike ning hoone kaitseomadused tagavad evakueerimiseks küllaldaselt pika aja.



Evakuatsioonitool on olemuselt roomiktool, võimaldab horisontaalset ja vertikaalset evakuatsiooni. Toolid paiknevad koridorides või trepikodades kokkuklapituna ja seina külge kinnitatuna. Evakuatsioonitool on hea abivahend haiglatesse ja hooldekodudesse, kus on palju ratastoolipatsiente ning hoone tulekaitse tagab piisavalt pika aja evakueerimiseks.



7. KASULIKUD LINGID

Päästeameti ohutusportaal <https://ohutusportaal.paasteamet.ee/>

Ehitisregister <https://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1>

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet <https://ttja.ee/>